分类号：B849　　学校代码：10114

密　级：_____　　学　号：2012100519

山西医科大学

SHANXI MEDICAL UNIVERSITY

硕士学位论文

医患沟通障碍中认知的质性分析

Qualitative analysis of cognitive impairment of doctor-patient communication

研 究 生：李　杰

指导教师：姜　峰　教授

专业名称：应用心理学

研究方向：学校卫生

学位类型：学术学位

所在学院：人文社会科学学院

中国　山西

二〇一六年六月二十七日

中国知网　https://www.cnki.net

分类号: B849　　学校代码：10114

密　级: _____　　学　　号：2012100259

医患沟通障碍中认知的质性分析

Qualitative analysis of cognitive impairment of doctor-patient communication

研　究　生：李　　杰

指导教师：姜　　峰　教授

专业名称：应用心理学

研究方向：学校卫生

学位类型：学术学位

所在学院：人文社会科学学

中国　山西

二〇一六年六月二十七日

中国知网　https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

中文摘要 I
英文摘要 III
1 引 言 1
1.1 问题的提出与研究意义 1
1.2 国内外相关研究综述 3
1.3 研究方法 13
1.4 数据来源与处理 14
1.5 论文框架 14
1.6 论文创新点 14
2 医患双方质性研究 16
2.1 研究目的 16
2.2 研究对象 16
2.3 实施方法 16
2.4 研究工具 16
2.5 研究结果 17
2.6 讨 论 22
2.7 问卷的信度与效度检验 25
3 患者的个案干预研究 26
3.1 案例背景 26
3.2 研究对象 26
3.3 患者背景资料 26
3.4 作者了解的情况 27
3.5 作者的观察 27
3.6 家庭情况 27
3.7 情绪状况 28

中国知网 https://www.cnki.net

3.8 社会功能 28
3.9 心理测验结果 28
3.10 问题分析 28
3.11 进行干预 29
3.12 咨询过程 30
3.13 干预效果评估 31
3.14 讨 论 31
3.15 提升医患沟通水平对策措施 32
4 结论与展望 33
4.1 研究结论 33
4.2 对策（建议） 33
4.3 研究不足与展望 34
参考文献 35
附 录 38
致 谢 39
研究成果 40
个人简历 41

中国知网 https://www.cnki.net

医患沟通障碍认知的质性分析

摘 要

目 的：

通过对医患群体双方的情绪、行为及语言等认知层面因素的分析，初步探讨医患沟通障碍中的认知问题及成因；通过对典型医患沟通障碍的个案研究，初步探讨认知因素对缓解医患沟通障碍的影响。

方 法：

研究采用《医患沟通现状调查问卷》分别对忻州市某综合医院 235 名医务人员和 269 名患者进行问卷调查，通过对问卷分析初步筛选出对医患沟通影响较为突出的认知因素。分别对医务人员及患者进行一对一的半结构式访谈，深入分析影响医患沟通障碍的认知因素。选取访谈中典型的沟通障碍案例进行个案研究。

结 果：

1.调查研究结果

影响医患沟通障碍认知状况的主要因素，包括医患信任度、医方技术、医方态度、患者要求过高、患者知识差异、医疗费用、社会因素等方面。

2.质性研究结果

医患双方沟通障碍主要是双方认知存在偏差、语言沟通存在偏差、医护人员态度存在偏差。

3.个案研究结果

通过采用合理情绪疗法对患者进行心理干预，同时患者的语言及行为也随之改善，进而医患沟通障碍得到缓解。

中国知网 https://www.cnki.net

结 论：

1. 医患双方的认知因素能够影响医患沟通障碍。
2. 医患双方良好的认知能够改善医患沟通障碍。

关键词：医患关系；沟通障碍；认知；质性研究；个案

中国知网 https://www.cnki.net

Qualitative analysis of cognitive impairment of doctor-patient communication

Abstract

Objective:

We analysed the cognitive factors such as emotion, behavior and language which affects patients and doctors groups, and discussed the cognitive problems and the causes of doctor-patient communication disorders; Through a case study of typical doctor-patient communication disorders, we discussed the cognitive factors to alleviate the impact of the doctor-patient communication disorders.

Methods:

By using the questionnaire of the present situation of doctor-patient communication, we respectively investigated 235 medical staff and 269 patients in a general hospital in xinzhou city. Through analying the questionnaire, we preliminarily screened outstanding cognitive factors which influenced on doctor-patient communication. For medical staff and patients respectively one-to-one semi-structured interviews, we analysed the cognitive factors affecting doctor-patient communication disorders.Then we selected a typical interview case of communication disorders to study.

Results:

1.Results of investigation and study

The main factors that influenced the doctor-patient communication disorders cognitive status, which included the level of doctor-patient trust, the medical technology, the doctors' attitude, the serious patients' demand, the difference of patients' knowledge, the medical expense, the social factors and so on.

中国知网 https://www.cnki.net

2.Results of Qualitative Research

Doctor-patient communication disorders mainly based on their the cognitive bias, the deviations in language communication, the deviations of medical staff attitude.

3.Results of Case study

By adopting reasonable mood therapy for patients with psychological intervention, then the patient's language and behavior has been improved, and can improved the doctor-patient communication disorders.

Conclusions:

1.Both doctors and patients cognitive factors can affect doctor-patient communication disorders.

2.Both doctors and patients good cognitive can improve doctor-patient communication disorders.

Key words: doctor-patient relationship；communication disorders； cognitive；qualitative research； case study

中国知网 https://www.cnki.net

1 引 言

1.1 问题的提出与研究意义

近年来，随着社会经济的长足发展，我国的医疗水平不断提升使得医疗事业获得了不错的成效，进而使得各级医院基本能够满足百姓的看病就医的需求。使得我们国家的各族人民都得到了更好的医疗保障。虽然民众从医院中得到的医疗保障越来越全面，但患者与医生的沟通交流却越来越困难。医患关系逐步恶化，从零星的个别现象逐步演变成社会关注的热点话题、敏感话题。医生和患者及家属之间都存在着对信任的缺失、在交谈和表达自己的意思时均不能够表达完整且被对方歪曲自己的意思，这些都是我们日常看病就医的过程中遇到的、同时也是医患矛盾不断升级、紧张和激化的原因[1]。根据我国的国医师协会在 2004 年发表的《医患关系调研报告》数据中明确的显示有将近 75% 的医生和护士认为自己的很多权益得不到法律的有效保障，他们认为目前的医护人员所处的工作环境中，其中“较差”和“极为恶劣”的达百分之六十以上[2]。日益紧张的医患关系不断的冲击着现今医护人员的心理底线，医护人员频频辞职及转行的现象逐年的增加。每当问起医务人员是否愿意让自己的子女与亲属的孩子从医时，他们总会坚决否定，由此可见医患关系之紧张，从医环境之恶劣。

面对如此不协调的的医患关系，学界和卫生管理机构除了要关注社会法律等宏观因素之外，还需要关注更加具体的，实际的心理及社会因素在医患沟通障碍中所起的作用。在我国的医疗大环境中，医护人员与患者及家属之间的沟通是最重要的，同时也是也是最基本的一方面。虽然目前一些高等医学院校向学生开设医患沟通选修课，许多综合医院也注重培训医生与患者及家属沟通方面的技巧，然而在临床的实际应用中，效果却并不那么尽如人意，由此也可以反映出一些问题，并不单单是通过医护人员者一方面有提高、改善就可以使医患沟通障碍的一问题得到很好的改善，还需要护着及家属的积极参与进来。因此说沟通是双方的，医患的沟通同样也是需要是医护人员和患者及家属之间的沟通。当医患沟通受到阻碍时，我们需从医生和患者两方面寻找原因。从医生角度有以下几方面原因：第一，医生与患者数量上的明显差异。患者多，医生少，致使医生诊疗任务加重，平均分配给每位患者的就诊时间明显减少，医

中国知网 https://www.cnki.net

护人员在就诊时，面对大量前来看病的患者只好在有限的时间内尽量看完全部的患者，由此可知，分配给每个患者的时间就只有短短十几分到及分钟，并且还要在这短暂的时间里对病情有一个全面的了解，进而做出正确的诊断和治疗。正是因为诊疗时间的急剧缩短，使得医生接待每位患者的时间也许仅有几分钟，因此就更不可能有时间与患者进行良好的沟通。医生既要满足患者的沟通需求，又要在有限的时间里完成巨大的诊疗量，而这两者不可兼得，医生只能选择后者，所以为造成医患沟通不畅，为医患关系紧张埋下了隐患。第二，患者对医生有着百分之百的期望---治好病，但又有着百分之百的怀疑。面临着如此期望和怀疑，医生的精神压力便会非常大。处在一个压力大、纠纷多的环境中，医生的出错率便会不断增加。而在相对和谐的环境中则相反，医生会对患者及家属履行详细的告知义务，而且服务态度较会更好。从而患者对医生也会更加信任及依从。医生面对如此之大的工作压力和责任，就会在诊疗过程中采用一些相对应对措施，比如选择逃避责任。比如减少诊疗时间，拒绝接待患者，或在诊疗时将患者病情说的更为严重，或者只向患者交代部分病情，与患者及家属说话小心谨慎等。由此可知，为什么医护人员和患者及家属双方之间的交流会如此聊聊几句话，双方不能够明白对方的意思。这也就是致使医患双方不能良好的沟通的原因之一。第三，我们国家对于医疗行业尤其是对工作在医疗第一线的医护人员没有明确的法律法规，以及社会媒体对医护人员的怀疑态度。在我国，保障保护医务人员权益的相关法律很少，甚至是缺失的，而更多的法规将医务人员与患者置于不对等的地位，而且在实际的医患纠纷判例中法律更倾向于患方。正因为医务人员缺少最强有力的法律保护，因此只能依靠自己来保护自己的安全及合法权益。加之有些不良新闻媒体不实甚至抹黑式的报道，最终导致了医务人员形象的普遍受损，信誉度直线下降，导致患者对其信任度急剧下降，加深了医患矛盾。而从患者角度有以下几方面原因：第一，患者的自我权益的知识增强和运用法律的的意识同时也在不断的增强。在我国法律制度不断的健全和完善中，我们的广大患者及家属也随之不断的加强，同时，患者对医护人员也不像之前完全信任和遵从医护人员，现在的患者的第一反应是对医护的怀疑。加之患者对医疗服务的质量有了更高的要求和期望，不仅要求医生医术精湛而且还要求服务良好的态度，有时患者更加注重后者。从患者及家属的对应面——医护人员来说，医护人员在繁重的工作情况下，只能够也更重视看病救人的医疗技术，而相对忽视了患者及家属的治疗疾病以外的隐形要求。就此可以说明一些问题，而这些原

中国知网 https://www.cnki.net

因造成了医护人员与患者及其家属之间的不能很好的沟通、不能很好的相互信任。第二，患者的心理问题因素。患者到医院医院就诊虽然只是寻求医生解决其身体的疾病，但患者自身可能还存在某些心理问题，但其并不自知，有时即便自知也未明确告知医生。因此，医生在未获得患者全面信息的情况下进行诊疗，可能在治疗过程中，患者因其自身心理问题会不自觉得带出负面的情绪。而此时医生若不关注患者的不良情绪时，那么就会出现沟通不畅的问题。

纵观目前国内外对于医患沟通的研究，多数学者使用量表进行相关的研究，而相关量表在国内仅有对医学生的问卷，但是对一线临床医生却没有信效度较好的相关问卷。而且就类似问卷在使用过程中需花费大量的人力和时间，对于大量的大型的研究是不适合的。而且多数问卷仅是单一对医生、护士或者患者的相关研究，没有医患相互对等的相关研究。

认知心理学是一种对人类是怎么来感知周围的事物、如何学习的、记忆是怎样的规律、以及是如何思考问题的这一学科。认知即人的思维。质性分析是直接面对研究对象、重复社会现象的一种反映。本课题充分利用认知心理学及质性研究相关理论，对医患沟通障碍认知进行质性研究

本研究旨在通过访谈者—医生/患者一对一的半结构式访谈，呈现出医生(患者)在医患沟通障碍中的认知、身心状态及行为方式等。探寻医生（患者）的认知这一角度在医患沟通障碍中的影响因素。本研究是通过对医患沟通障碍中认知的质性研究，发现和探讨医患沟通障碍的原因，针对沟通中存在的问题，结合本地区实际情况有针对性的提出改进意见与建议，促进本地区医患沟通教育，有利于完善住院医师规范化培训的培养目标与培养方式，降低患者及家属对医护人员的敌意和防备，对减少因医患沟通不畅引发的医患矛盾，这样可以把我们的社会建设的更加和谐、美好，具有较好的现实意义。

1.2 国内外相关研究综述

1.2.1 医患关系的概念

中国知网 https://www.cnki.net

医患关系指医疗服务（即临床工作中）过程中客观产生的医务人员与患者及患者家属的一定医治关系[5]。医患关系有广义及狭义之分。通常来说，广义的医患关系：是说以医护人员为中心的医疗行业有关的相近的职业的这一方，以及以患者及家属为中心的与患者健康利益有直接关系的一方形成的两个群体之间的关系；而狭义的医患关系则仅仅指医生和患者及家属这两者双方个体间的关系，也就是说医护人员和患者及家属均是主体的主体与主体之间的关系[3]。医患关系是以患者的康健利益为集中点，两方在彼此同等及彼此依赖的基础上创立起来的富有人文互助精神的特殊人际来往关系。医患关系的是否良好对患者疾病的诊断、治疗及愈后这三方面有着重大的影响，故而良好的和谐的医患关系与患者最终是否能够以最好的治疗效果出院之间存在着密切的关联[4]。

1.2.2 医患沟通相关概念

沟通的概念

沟通是人与人以全方位信息交流所达到的人际间建立共识、分享利益并发展关系的过程[5]。沟通的模式大致可以分为语言沟通与非语言沟通这么最基本的两大类，。语言沟通是一种社会现象，亦是一种工具，人们可用来相互交流感情和思想，以达到相互了解、交往、生活和工作的目的。非语言沟通是指沟通双方积极的使用除语言以外的其他的任何形式的交流如：肢体、行为，甚至借助于“物”等[5]。

医患沟通

医患沟通英文表述大多是：Doctor-patient Communication。我们国内学者王锦帆教授对医患沟通进行了比较全面的释义，她指出狭义的医患沟通指在日常诊疗过程中医疗机构的医务人员与患者及其家属对诊疗服务的方式进行的沟通及交流。而广义的医患沟通是指医务人员、卫生工作管理者及医疗机构，同时还有医学教育工作者与患者及家属间的沟通交流。医患沟通的主要内容包括医疗信息和思想情感两方面的沟通[6-7]。

1.2.3 医患沟通的作用与影响

医护人员和患者及家属如果能够进行积极的沟通和交流，就会对患者的心理提供有效的心理安抚和支持，从而使患者能够更加快速和良好的康复。在目前生物-心理-

中国知网 https://www.cnki.net

社会医学模式下，大量临床治疗实践表明，心理治疗在任何疾病的诊治过程中都不可忽视，而心理治疗的前提首先是基于良好而顺畅的医患沟通[8]。

首先，和谐友善的医患沟通是有利于医护人员对患者的病情有一个全面详尽的了解，以此来做出正确的诊断和完善的治疗方案。医生询问病史的过程其实就是医生与患者间的双向沟通交流的过程，医生在这一双向交流的过程中可以收集到患者患病的整个过程中的详尽的资料，如患者的主诉、此次就医的发病情况、既往史、过敏史、用药史等，第一次见面是医患双方的沟通和交流是影响之后的诊断的准确性、治疗过程是否非常严谨等都会有着重要的影响[9]。

其次，和谐友善的医患沟通更加有利于保护患者及家属的权利，可以使患者及家属了解在医院期间所享有的基本权益。其中至关重要的是患者及家属对在治疗过程中遇到的知情同意的权利，同时这也是在医患沟通中能够完全充分的体现出来的。在医患沟通的过程中，医生对患者的病情的解释，就是在了解患者还存在的问题与困惑，并及时予以解答，增加医患双方的信任度；患者也应该积极的良好的与医生的交流、接触，弄清楚疾病的治疗方案、检查项目、用药情况、医疗风险和预后、健康转归、医疗费用等一系列问题，这样患者在综合考虑所有利弊后作出适当的选择[9]。

再者，和谐友善的医患沟通更加有利于医护人员与患者及家属建立相对密切信任的关系。医护人员由于拥有非常专业的知识，而患者及家属则对医学知识是没有的，因此医患之间的医疗信息是不对等的，也因此可以说医生在沟通中是处于一个较为中心主导的位置，由此会造成一个现象就是：医护人员在讲专业术语，而患者及家属却没有明白医护人员的全部意思，致使患者及家属容易理解错误医护人员的意思，从而导致双方沟通不畅，产生双方的不满和猜忌。甚至有形成医疗纠纷的隐患[9]。

最后，和谐友善的医患沟通更加有利于我们国家的一线医院的良好发展。就目前的紧张的、不断恶化的的医患关系的大背景之下，我们必须积极努力的改善和缓解医患双方不良的现状，尤其是加强医护人员和患者及家属的沟通流畅程度和彼此之间的信任程度以及相互的理解和尊重。而且也能赢得广大病患的信任和爱戴，缓解较为紧张的医患关系[9]。

中国知网 https://www.cnki.net

当今，许多疾病的发生与发展背后都隐藏着很深的心理因素，而纾解和消弭心理障碍的重要手段就是良好的医患沟通。正如有的医生所言："现在对病人的治疗，首要的是谈话交流，其次才是治疗[10]。"

故而本研究确信,和谐友善的医患沟通是缓解和改善医患关系恶化和减少医患纠纷的最有效的途径之一。和谐友善的医患沟通，不仅能够在消除患者身体上的疾病，还能安抚和缓解患者心理上的创伤，最终找到医患双方都能够满意的平衡点，即双赢的结果。

1.2.4 医患沟通的影响因素

医患沟通的发生是会某种特定的环境之下，而这种特定的环境是有很多因素在其中起作用的，因此在医患沟通的过程中都要积极的适应特定的环境因素，才能够有良好的沟通。那么，通常而言医患沟通会受到的影响大致可有以下三种因素：心理的、文化的和物理的因素[11]。

(1)心理因素

心理因素主要指医患双方的态度和情绪。它包含两个方面的内涵。其一，沟通主体自己的心情、情绪。当沟通的主体（即：医生讲解患者现在的状况时或者是患者及家属想要知道能多患者疾病的相关信息时）处于主动地位或表述状态或是求知的状态时,那么其沟通的意愿、行为等都是表现积极的[12]。其二，沟通主体如何对待对方的感受和态度。如果沟通一方对另一方存在怀疑及不友善等态度,都会对沟通的流畅程度以及最后想要达到的结果造成破坏性的影响。因此,医患双方只有相互信任，沟通才能有较好的效果。

(2)文化因素

文化因素主要是指沟通主体（医患双方均为沟通的主体）的知识结构、思维逻辑和价值观等的总和。首先，由于医患双方的生活环境以及接受到的教育层次不同,造成了不同的文化学识背景,如果在平常的交流中是不存在任何问题的，医患双方的自我表达的意思也是相同的，但是当双方面对面的进行有关病情的交流时，就常常会发生沟通不了、不顺畅等现象，即沟通障碍就会出现。因此，就需要医护人员的耐心和深入浅出的与患者及家属进行沟通，同时患者及家属也要积极的理解医护人员所讲的医疗知识。其次，语言是有感情色彩的，医务人员在与患者沟通过程中对一些在患者

中国知网 https://www.cnki.net

眼中敏感的字眼、话语相对理性或比较麻木，从而导致与患者及家属沟通时可能会出现沟通障碍或不畅。

(3)物理因素

物理因素主要是指医患沟通发生在不以人的意志力为转移的客观环境,物理背景的不同往往会产生相应的沟通氛围,某些特定的物理环境是有利于创造良好的沟通氛围的。比如干净、整洁的办公桌,会使患者感到心情愉悦,让患者对医生产:“这个医生我是可以相信的，你看他的办公桌是干净的，那么他在个人看病的时候肯定是清楚的，一丝不苟的。”的第一印象。从而使患者对医生少了猜忌多了信任，沟通就会变得顺畅。安静的场所,也有助于医患双方的正常沟通与交流，反之嘈杂的环境会使患者情绪烦躁、感到不安，进而影响正常交流。

1.2.5 认知的概念

认知过程(Cognitive Process)是主体即人对客观世界（事实存在的）的认知和察觉，包括我们对周围事物感觉和知觉、我们对事物的记忆、思维方式、注意力等心理活动过程。反映论将此过程视为客观事物在人脑中的反映，而现代信息论视其为人脑对客观世界变化信息的加工过程[13]。大脑接受外界输入的各种信息，经过综合加工和处理，转换成人的心理活动，进而支配人的各种行为，这个过程就是信息在大脑中加工的过程，也就是心理学中所说的认知过程。[14]认知过程是心理行为的决定因素，包括：①认知活动会影响行为；②认知活动是可以调整和控制的；③通过认知的改变可以造成行为的改变。即认知情绪和行为的产生依赖于个体对环境与事件的评价，评价源于认知的作用和影响，如果个体有不合理信念的认知存在，就会导致不适应的行为和不良情绪的产生[15]。因此认知的差异会产生行为的差异。

医患沟通过程中,由于医护人员和患者及家属双方在知识背景、专业领域的不同、医学知识吸入等具有自己的掌握程度和理解程度的差异,从而使医护人员和患者及家属在沟通中有着不同的理解和想法以及态度处事方式,也就造就了医护人员和患者及家属在沟通过程中有着各种各样的处理问题方法和态度，进而出现矛盾和冲突[16]。有研究表明,医护人员和患者及家属双方认知的不同是导致医患沟通障碍的较为深层次诱发原因[17]。因此我们如果处理好了医患之间的认知不同，那么对于创建和谐医患关系有着重要、密切的作用。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2.6 医患沟通国外研究现状

自从在 1949 年中，日内瓦协议中的医学伦理学就有一项规定:医生要宣誓把自己的一生奉献给人道主义并为其服务,凭着一颗良心和自我的尊严行使医生这一高尚的职业,无论任何时候首先要考虑的是病人的生命和健康，在医生的职责和病人的生命和健康之间是坚决不允许任何把对宗教、国籍、种族、政党和社会党派等政治人文因素参杂进去，而且即使受到威胁，作为医生也将要以最大的努力，尊重从胎儿时期开始的每一个人的生命,坚决不利用医学知识做任何违背人道法规[18]。之后在 1956 年时,美国的 Szas T.S.和 Hollander M.H.在他们共同协作写就的论文《医生一病人关系的基本模型》中,提出了医患关系的主动一被动型模式、引导一合作型模式和共同参与型模式的这三种基本模式[19]。

随之在 1989 年世界医学教育联合会著名的《福冈宣言》指出："所有医生必须学会交流和处理人际关系的技能。缺少同情应看作与技术不够一样是无能力的表现[20]。"合格的医生除了应具备精湛的医疗技术之外，还应不断提高与患者之间交流和沟通的综合能力，这项综合素质是必不可少。沟通能力是医疗活动的基础。良好的沟通交流有助于医生对患者信息的采集、疾病诊治及病人的教育[21]。很早之前美国的一些医学院校就提出并实践了对医学生沟通能力的培养，在课程的安排上和教学方式中都增加和融入了与患者沟通的相关内容， 如《医患沟通的艺术》、《医生与病人相处的能力》及《如何告诉病人坏消息》等书籍和相关课程向医学生讲授与患者沟通的方式方法和技巧，目的在于加强从医学生起就开始培养的临床沟通与交流能力[22]。

美国医学院协会(The Association of American Medical Colleges)和美国医学教育联络委员会(The US Liaison Committee on Medical Education)等组织要求医学教育工作者在培养未来医生时,全面的评估医学生在临床工作中与患者交流技能,使其不仅具备精湛的医疗技术,还应该更具有良好的与患者的沟通能力。在欧美等多个国家的学术界大多数倾向于对与患者沟通技巧的研究,而这些研究大多数以 Roter 沟通分析系统的基础上进行的。Roter 沟通分析系统[23] （Roter Interaction AnalysisRIAS）是一个专门应用于测量医患沟通的分析工具[24-26],它广泛应用于美国[27、28]和其他语言国家[24-25]的很多医患沟通的研究。2006 年 Roter 沟通分析系统经经过数次的修订后将医患沟通分为：语言性的沟通和非语言性的沟通。语言性的沟通有两方面，一方面是情感

中国知网 https://www.cnki.net

沟通，另一方面是医学专业信息沟通。Roter 沟通分析系统将医患沟通的过程分成三阶段:①开始阶段:医护人员在与患者及家属第一次见面时可以先进行打招呼并且作自我介绍，从而可以营造出一个相对和谐的氛围使患者有一种被尊重的感觉,之后再进入主题,与患者就病情进行全面的了解等。②中间阶段:作为医护人员与患者及家属沟通交流的最重要的阶段，医生需要通过患者及家属才能搜集到完整、真实的相关资料。比如：病人的主诉、既往史、以往的疾病资料等，均是直接影响医生正确诊断和治疗方案的重点。③结束阶段:包括医生与患者对病情的讨论,给出诊断结果，提出治疗方案,给予具体意见,并向患者简要总结诊疗过程。

1.2.7 国内医患沟通研究现状

近年来，随着我国医疗事业的不断发展，多家医院频繁发生医疗纠纷、患者打砸医院及暴力伤医事件，全国各地医疗纠纷数量明显上升，医患矛盾有激化的趋势,因此医患沟通越来越受到各医学院校和医疗卫生机构的重视。在 2003 年年初重庆市卫生局在全国卫生工作会议上,向大会介绍了重庆医科大学附属儿童医院实施的“医患沟通制”的做法和效果以及推广和体会[14]。同年，由全国五家著名医药院校专家合作编写的我国首部《医患沟通学》面市，标志着我国医护人员有了第一本本土的医患沟通教材。此后全国各地的医疗机构先后将医患沟通制度落实到医疗活动中,在医患沟通医学教育方面，相比发达国家而言，我们目前还处于比较落后的阶段。我国目前在对医学生的培养和在职医生培训中,医患沟通教育方面尚无系统化的培养课程,医生和医学生的沟通能力参差不齐，多数医患沟通方面存在明显的不足和缺陷。而我国学者在借鉴国外的医患沟通研究经验的前提下,不少学者也在编著适合中国国情的医患沟通专著，如《医患沟通理论与实践》,《医患冲突的沟通与解决》、《临床医患沟通与交流技巧》和《病房警示录——医患沟通案例评析》[25]。2009 年，国内学者程全和邓云龙初步合作编制了《医学生医患沟通行为量表》来研究医学生的医患沟通行为,并对 160 名医学实习生进行了测试,结果表明该量表可以用于我国医学生医患沟通行为的评价[29]。目前，虽然国内对于医学生的医患沟通研究逐渐从理论趋于实践,但依旧没有形成系统的医学院校医患沟通培训课程。我们应当借鉴国外医学院校的成功经验,建立适合我国医学生的系统化培训课程,以此加强医学生医患沟通的能力[30]。

中国知网 https://www.cnki.net

综上所述，面对日益紧张的医患关系，我国学者和医务工作者在不断的寻求解决的方案。也因此说明了，医患沟通障碍是导致医患关系紧张的重要原因之一，其影响巨大，作用关键。因此，采用质性分析的研究方法研究医患沟通可以从临床医生和护士及患者手中了解到具体的，真实的、有意义的一手资料。从而可以更好的为改善医患关系紧张和建设和谐的医患关系，提供建设性的意见和建议。

1.2.8 医患沟通国外评估

欧美等发达国家对医生沟通能力的评价方法明显较国内多。以下是国外常用的主要评价方法。

(1)专家评价法

专家评价法是通过观察研究对象的沟通行为等方式，由临床各领域专家对研究对象的表现进行评价；美国和加拿大已将专家评价法作为主要评价沟通行为的方法[31]。专家评价法是通过对医患间的互动行为进行评价，患者采用真实的或者模拟病人，专家都能较为准确的评价医生在医患沟通过程中的行为。专家评价法常用的评价方式有:互动分析系统和观察评分系统[32]。互动分析系统是首先对沟通行为中的不同主题进行编码，评价者必须熟练掌握编码内涵，然后基于医患间的交谈录音或录像进行客观评价。

(2)自我评价法

自我评价法是研究对象本人对自身行为状态和总体状况进行主观的测量，采用的是自我检查的形式获得评价信息。这种方法能够使评价者通过测量自我行为，了解自己的行为，最终达到自身改进行为的意识和提高。但由于是主观测量，存在一定的误差；只适用于多种方法结合使用时的其中一部分。

(3)患者评价法

患者通过自我感知来评价被调查者的行为、认知、态度和满意度等，结果来自患者对医生行为的主观感受。美国毕业后医学教育认定委员会(ACGME)和美国内科医学委员会(ABIM)联合倡议的评估方法中将“患者评价法”单独列出来，并认为这种

中国知网 https://www.cnki.net

评价法具有较高的价值是可以获得推广的[33]。国外评价医生沟通行为的文献中可看到，较多研究引用了美国内科医学委员会编制的“患者满意度”调查问卷。

(4)标准化病人(SP)和标准化家庭(SF)评价

标准化病人：正常人或病人通过标准化、系统化的培训后，准确表现出病人在实际的临床上所出现的症状和体征，标准化病人评价法通常也作为临床能力评估方法之一。在测评中，要求标准化病人不仅能够完成表演课程中所要求扮演的角色，也要求能够与被考核者进行相应的信息反馈，更要求能精准的观察被考核者的行为。

(5)多源反馈评估法

多源反馈评估，是由与被评价者有密切关系的人对被评价者的评价以及被评价者的自我评价，他人评价包括:被评价者的上级、同事、下属、顾客；获得的评价来自各个方面，更容易促使被评价者改进自我的行为方式[34]，该测评法客观性强，可对多种变量进行控制。

1.2.9 医患沟通国内评估

目前国内对医患沟通能力评价的研究很少，仅有的医患沟通评价研究中大多是针对医学生和护士的沟通能力的评估，而真正在临床工作的医护人员的沟通能力的评价的研究却很少。我国最早对沟通技能的评价研究是也仅仅是对护士的评价。2004 年第二军医大学叶倩编制了护士沟通技能评价自评问卷，包括自评测试、模拟情景测试和开放式问答共三部分，通过反复的修改验证最终确立问卷，并通过统计学分析获得了较高的信度和效度[35]。2008 年中南大学博士彭红参照国外相关量表和国内护患沟通能力等量表编制了《医学生医患沟通能力测试量表》，该表采用自评和他评的方式，通过对量表的反复验证，从 78 个条目最终确定了 50 个条目，能较为客观的评价出医学生沟通能力情况，并通过检测获得高的信度和效度[36]。2008 年中国医科大学李娟采用 Gregory Makoul 等学者编制的 SEGUE Framework 量表观察测量本校医学生的沟通技巧，评价方式是专家评价医学生与 SP 交流情况[37]。2010 年，中国医科大学张阳的研究结果认为我国住院医师职业道德和交流情况是总体水平较好[38]。总之，国内对住院医师沟通技能的研究较少[39]。

中国知网 https://www.cnki.net

综上所述，专家评价法，用于国外且都是由临床领域的专家进行研究，不适合我国人口密集的医院，而且在医患沟通中更不可能进行同步的观察和分析。而自我评价法中的问卷是患者对医生行为的一种主观感受，不能够客观的评价医生行为，而且也不是专门针对“医患沟通”这一项进行测量的问卷。标准化病人(SP)和标准化家庭(SF)评价，在我国此种方法显然实施方面难度极大，且耗时耗力、不简便。因此，也不适用于本研究。虽然，多源反馈评估法相较其它的考评法准确、误差少，能避免考核中容易出现的由情感因素造成的“个人偏见”、“光环效应”、“居中趋势”和“考核盲点”等现象[32]。但是，医患沟通是医生和患者及家属双方的直观感受和交流，是医生通过自己掌握的知识及经验对患者的病情进行诊断分析的一种交流过程。而医患双方间的这种交流也不是医生的上级、同事、下属等能全面了解和掌握的。因此，此方法虽然优点很多，但是在对医患沟通研究方面而言，此方法仍是不可取的。故而，国内的医患沟通的相关量表目前仅有对医学生明确的问卷量表，但是对临床医生却没有信效度较好的相关问卷量表。

医患沟通是一个复杂的、多元的社会现象，量化研究是不能够完全明确解释和说明的。故而，本研究决定采用质性研究对医患沟通中的出现的现象进行解释性的理解。质性研究的定义是指在自然情景下的研究，研究者本人即是研究工具，采用多种资料收集方法对社会现象进行整体性的探究，用归纳法分析资料并形成理论，通过与研究对象互动，对其行为和意义进行建构获得解释性理解的一种活动[40]相较于量化研究而言，质性分析的优势在于能够对目前不太清楚的社会文化现象做出解释性的理解，以提供深入研究的线索和理论雏形[41]。质性研究具有归纳式的研究思路，强调研究的深度，研究程序富有弹性等特点，研究中允许使用小样本和个案，深入真实而具体的社会情境，努力不造成干扰或破坏，使被观察的社会现象更真实地表露。医患沟通过程中因为有人的存在而变得非常复杂又充满意义，而这些意义的解释是多元的必须要通过研究者的主观参与才能被理解；质性研究是将简单的问题复杂化，才能明了意义的情境性和多重性[42]。质性研究适用于研究“描述性问题”和“解释性问题”，因为这两类问题可以对现象的状态和意义进行探究[40]。综上，本课题对“医患沟通障碍”的研究正是与质性研究的范围及含义吻合，因此选用质性研究。

中国知网 https://www.cnki.net

1.3 研究方法

1.3.1 研究对象

本课题研究随机选取山西省忻州市某综合医院的235名医护人员与269名住院患者进行调查问卷研究。医生要求是具有临床诊断或护理经验超过1年以上；患者为住院治疗的患者。同时采用SPSS软件进行统计分析，初步筛选对医患沟通影响较为突出的认知因素。对部分医生与患者进行半结构式深入访谈，最后选取1例典型的医患沟通障碍案例进行个案研究。

1.3.2 研究内容

医患关系作为当前一种易发冲突的关系，一些地方医院频发医患冲突，纵然有医疗技术方面的问题，但更多的是医患之间没有良好有效的沟通，最终导致医患关系紧张，甚至发生恶性冲突事件，引发社会矛盾。切实有效的沟通对策，有利于构建良好的医患关系，有利于促进社会和谐稳定。本部分对研究和调查对象进行阐释性说明，对本课题研究所采用的问卷调查、质性分析、个案研究等研究方法进行介绍；对医患沟通障碍认知的质性研究相关调查的实施；对调查的问卷的信度与效度的检验，分为被调查者概况、沟通行为各要素评价结果、调查医生被评综合得分三个方面；对调查结果进行了评价。对医患沟通障碍认知问题及其成因进行了分析，结合调查实际，提出解决医患沟通障碍的对策措施。

1.3.3 具体方法

为了对课题进行深入研究，笔者系统复习了相关心理学理论，对沟通障碍、医患关系等概念进行了深入细致的剖析研究，系统掌握了相关调查研究的方法与手段，为本课题研究的顺利完成奠定了坚实的基础。本研究采取理论与实践相结合的方法，根据掌握的相关理论知识，通过问卷调查、质的分析、个案研究等方法，对医患沟通障碍医患双方的认知进行质性研究。首先，发放调查问卷，分别对医生和病人发放调查问卷。其中医生235名，患者269名。初步了解医生和患者在医患沟通的认知方面的基本情况。收集资料的方法为深度访谈，以面对面的形式进行交流，自行设计的半结

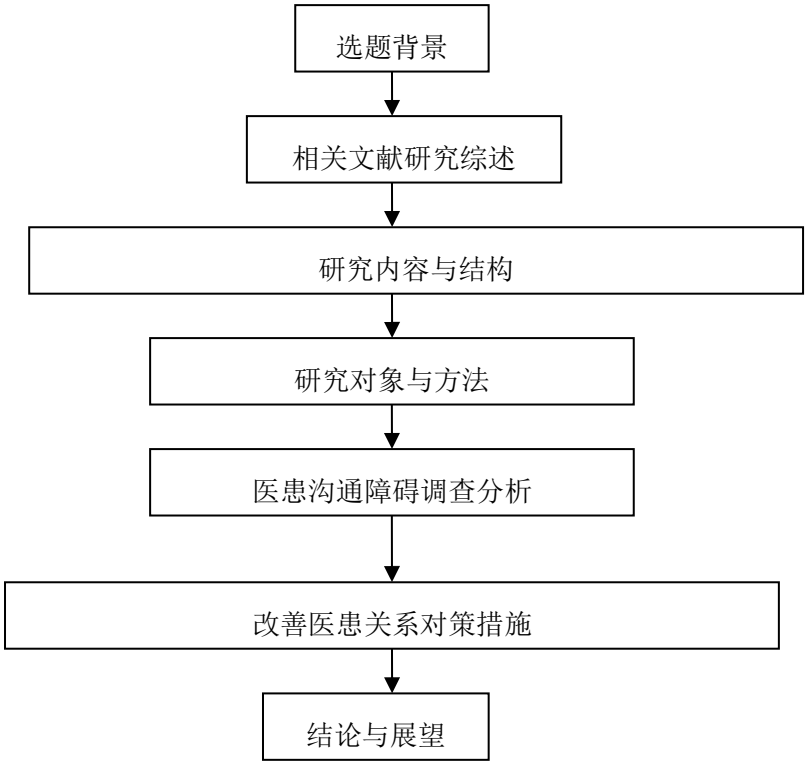
中国知网 https://www.cnki.net

构式访谈提纲为研究工具。从医生和患者中选取沟通障碍较为典型的案例进行个案研究。

1.4 数据的来源于处理

本课题研究随机选取山西省忻州市某综合医院的235名医护人员与269名患者进行调查问卷研究。医生要求是具有临床诊断或护理经验超过1年以上；患者以住院治疗的患者为主。同时采用SPSS17.0软件进行统计分析。

1.5 论文框架



1.6 论文的创新点

（1）给出了医患沟通认知的定义。

中国知网 https://www.cnki.net

（2）研究对象为医患双方的认知状况。以往的研究多以单方群体作为研究对象，而本研究涉及沟通障碍双方的认知。

（3）本课题通过对医患双方群体的认知进行质性研究，能够更完整系统的对医患沟通障碍的成因进行探讨。

中国知网 https://www.cnki.net

2 医患双方质性研究

2.1 研究目的

（1）通过向医患双方发放调查问卷，初步了解医生和患者在医患沟通的认知方面的基本情况。

（2）通过对医患双方的认知进行质性研究，探讨医患沟通障碍的双方在认知方面的原因及影响因素。

2.2 研究对象

（1）在忻州某综合医院中，发放调查问卷，分别对医护人员和病人发放调查问卷。其中医护人员 235 名，患者 269 名。

（2）选择忻州市某综合医院住院患者为研究对象，进行访谈调研。本课题研究中的资料饱和样本数达到 8 例。

2.3 实施方法

（1）由研究者亲自发放调查问卷，按照科室进行发放问卷，先发放患者的问卷再发放医生的问卷。

（2） 本课题研究中的质性研究，笔者选择格拉泽的“目的性抽样”策略，选择忻州市某综合医院住院患者为研究对象，进行访谈调研。依据质性研究抽样截止的标准是以受访者的资料重复出现，并且资料分析时以不再有新的主题出现为标准。

2.4 研究工具

（1）采用《医患沟通现状调查问卷》医务人员版和患者版。

（2）半结构式访谈提纲

中国知网 https://www.cnki.net

2.5 研究结果

2.5.1 调查对象本情况

共发放 520 份，收回 504 份，有效收回率是 96.92%，其中医务人员 235 份，患者 269 份。受调查的医护人员 235 名，构成比 46.6%；患者 269 名，构成比例为 53.3%。医护人员要求是具有临床诊断或护理经验超过 1 年以上，患者则以住院患者为主。其中男性 215 人(42.6%)，女性 289 人(57.3%)，性别数据缺失 16 人，平均年龄为 36 士 1.5 岁。下表为医患双方人员构成比表 2-1

表 2-1 医患双方人员构成比

项 目	类 别	数 量	构成比（%）
调查对象	患者	269	53.3
	护士 医师	235	46.6
性别	男性	215	42.6
	女性	279	57.3

为了全面了解掌握医患沟通障碍认知状况的主要因素，课题组对医患信任度、医方技术、医方态度、患者要求过高、患者知识差异、医疗费用、社会因素等方面进行了分析，总结出了影响沟通障碍的主要因素，这些也是容易导致医患纠纷的主要原因。详见表 2-2 所示。

2-2 医患沟通障碍主要因素认知状况比较

项 目	患者比例(%)	医护人员比例(%)	x^2	P
医患信任度	84.9	56.6	36.06	＜0.001
医方技术	38.9	21.1	17.61	＜0.001
医方态度	17.7	51.5	47.89	＜0.001
患者要求过高	76	25.1	105.58	＜0.001

中国知网 https://www.cnki.net

患者知识差异	46.7	11.2	56.22	＜0.001
医疗费用	43.5	35.6	2.74	＞0.051
社会因素	37.5	13.8	26.8	＜0.001

续表 2-2

2.5.2 质性研究

(1) 预研究

通过预访谈形式，初步体会医患双方沟通过程中的一些真实想法后，认真参阅了相关文献资料，并征求导师及相关专家的意见，确定了相应的研究框架。为了进一步突出研究的针对性，与上述医院相关科室住院部医护人员的沟通交流，确定了以下主题：对医患沟通重要性的认识，对医生相关语言的心理感受，医生情绪对患者的影响，对相关医学健康知识的了解情况，对医患沟通的期盼是什么等等。具体访谈内容如下：

1）您认为与医生（患者）的交流对治疗疾病有作用么？您与医生有较为充分的沟通吗？您与医生进行沟通中存在哪些障碍？

2）您认为医生与自己沟通重要，还是自己主动与医生沟通重要？

3)当医生与自己沟通不畅时，自己心中有什么想法？会不会有讨厌医生的想法？会不会有想逃避医生？您记恨医生吗？

4）当自己与医生产生沟通障碍时，对自己的治疗有什么影响？比如：会对家人发火？会对治疗产生失望情绪？您是如何排解这些问题的？

5）当自己与医生产生沟通障碍时，最希望得到哪些人的什么帮助？

6）您对医生说出的有关疾病的敏感字眼，心理感受怎样？

7）医生的情绪对自己有什么样的影响？

8）您对相关的医学健康知识了解吗？

9）您对医院的诊疗流程熟悉吗？医生是严格按照这些流程进行诊疗的吗？

10）您对医患沟通有什么样的期盼？

同时，笔者根据具体情况，对一些开放式的问题及半结构化的访谈，进一步完善相关访谈提纲，使其更贴近实际情况。

（2）患者的研究结果

中国知网 https://www.cnki.net

由于患者处于住院治疗期间，表现的较为敏感、浮躁，心理较为脆弱，特别是那些患有疑难杂症的患者，他们心情一般较为低沉。为此，笔者采取了一对一的半结构访谈作为收集资料的主要方式，这样可以有效减少病人的抵触情绪。在进行正式访谈之前，首先向患者说明来意，并对研究的目的进一步进行说明，打消患者的疑虑，在征求本人同意的基础上，签署《访谈同意书》后，开始访谈，（见附录）。

访谈过程立足于住院患者实际情况，灵活安排访内容与时间，除了完成既定的访谈提纲外，还积极鼓励受访病人主动提出其他相关的问题，对一些问题坦诚相见，讲出自身的观点。

第一次访谈均采用面对面的方式进行，地点选在住院部医生办公室，利用患者治疗的间隙进行访谈，尽量排除外界的干扰，时间控制在 20 分钟以内，最长一次 36 分钟，最短一次 18 分钟，平均 20 分钟左右；第二次访谈则以问卷调查的形式进行，仅为核实信息的准确性。

借鉴 Colazzi 七步法进行资料分析。具体步骤如下：一是认真分析阅读访谈纪录。二是选出访谈中最具价值的资料。三是对重复出现的观点进行编码。四是将编码后的观点进行汇总；五是进行全面描述；六是找出类似观点；七是反馈受访者情况。根据扎根理论，得出以下编码，如表 2-3 所示。

表 2-3　住院患者的真实体验编码结果及典型情境

三级编码	二级编码	一级编码	典型情境
患者在进行沟通过程中的一些真实体验	沟通重要性认识	很看重	INV5：“沟通是很重要，患者是弱势群体。由于治疗期特殊的生活状态，如果沟通出现问题，就会出现一些负面影响。”
		无所谓	
		愤怒	INV3：“在用药、病情发展、下一步诊疗方案等方面，医患之间沟通不充分，有的存在医生故意隐瞒患者患病实性，让我感到无比愤怒！”
		失望	INV4：“有的医生对患者考虑不周，缺乏对患者的人性关怀，从不回避一些诸如死亡、癌

中国知网 https://www.cnki.net

续表 2-3

	心理应激及情绪反应		症、无药可救等敏感词句，让我心里产生对未来失去信心，感到世界是一片灰暗！”
		倦怠	INV2：“有的医生对患者漠不关心，每天的查房都是一样的说法，一样的治疗方案，一样的药物，让人感到十分的倦怠！”
		正能量	INV1：“有的医生以事业为重，以患者为重，坚持把个人的获得的知识技能，用到帮助患者解除病痛！”
	需求与支持	心理安慰	INV6：“有的医生对患者十分关心，能够放下身段，与病人站在同一个平面上，把患者作为自己真实的朋友！”
		被尊重	INV7：“有的医生对患者十分关心，能够放下身段，与病人站在同一个平面上，把患者作为自己真实的朋友！”

（3）医护人员的研究结果

对于医护人员的访谈过程立也类似于患者的访谈过程，也是给予医生工作的实际情况，灵活安排访谈，除了完成既定的访谈提纲外，还积极鼓励受访对象主动提出一些别的问题，鼓励坦诚谈谈对某些问题的看法。首次访谈也均采用面对面的方式进行，地点选在住院部医生办公室，利用医生工作或午休间隙进行访谈，尽量排除外界的相关扰乱，时间尽量控制在 15——20 分钟以内，最长一次不超过 40 分钟，最短一次不少于 10 分钟，平均 25 分钟时间；第二次访谈则以问卷调查的形式进行，仅为实信息的准确性。同样，借鉴 Colazzi 七步法进行资料分析，具体步骤如图 4-1：一是认真分析阅读访谈纪录。二是选出最具价值的东西。三是对重复出现的观点进行编码。四是将编码后的观点进行汇总；五是进行全面描述；六是找出类似观点；七是反馈受访者情况。运用扎根理论得出一二三级编码，如表 2-4 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-4　医护人员的真实体验编码结果及典型情境

三级编码	二级编码	一级编码	典型情境
医护在进行沟通过程中的一些真实体验	沟通重要性认识	很看重	INV5：“沟通是很重要，医生也是人，有充分的相互沟通就可以消除与医生间的隔阂。如果沟通出现问题，随之就会出现怀疑，质问的口气等。”
		无所谓	
		愤怒	INV3：“患者没有任何医疗卫生知识，对治疗流程、方法、现代医学发展情况了解十分有限，医患之间沟通不充分，对医生产生的误解、忌恨让我感到无比愤怒！”
	心理应激及情绪反应	失望	INV4：“有的患者认为自己来医院就是让医护人员来服务的，对医生的工作不支持，以为有钱就行，甚至要大盘，与大款型患者，我们收入与工作量不成正比，让我感到前途十分失望！”
		倦怠	INV2：“有的患者存在对自己失去信心，对医护人员漠不关心，对每天的沟通，患者都是些流程化的对话，让人感到十分的倦怠！”
		积极配合	INV1：“有的患者十分积极，对医护人员的治疗十分配合，与其沟通不存在障碍，看着患者一天比一天健康，我很有成就感！”
	需求与支持	心理安慰	INV7：“有的患者看到我们认真负责为患者，说一句大夫你们真是辛苦啊，顿时我心理就觉得我的付出是值得的。”
		被尊重	INV6：“有的患者对医护人员十分尊重，对医护人员的辛苦比较理解，把医生作为自己真实的朋友！”

中国知网 https://www.cnki.net

2.6 讨论

（1）患者的质性研究的结果讨论

首先，就患者而言，随着社会的发展，患者的法律知识的普及和自我权利意识的增强，不仅对医疗技术水平不断的提高要求，更多的是对医疗行业的服务有了要求，并不断的提升中。对治疗成效的期望值过高，常常造成医疗服务过程或结果与患者及其家属的期望产生较大的偏差，使患者对医院及医务工作者产生错误的理解。其次，患者来医院的看病是其显性目的，但其并不仅仅是解决生理问题这一显性目的，还有隐形目的--其心理上寻求安慰的目的，期望紧张、不安、焦虑、恐惧、痛苦、抑郁的情绪获得缓解与释放，另有社会学方面的目的，即补全缺失社会功能即痊愈到病前的正常状态。因此患者期望被关注、理解、接纳、尊重、照顾、帮助、支持。患者及家属不仅仅是要求治疗生理上的病痛，还怀有如此多的需求与期望来就诊，而作为我们的医护工作者只是检查治疗生理上的疾病，并没有思考过他们同时也有情感的需求。当患者情感方面的需求没有得到及时满足是，就会对医院产生怒气，对体制有怨气，对疾病有丧气等倾向，从而患者就会变得焦虑、惊恐、乃至恼怒，此时极易发生医患纠纷。

（2）医护人员的质性研究的结果讨论

就医护人员而言，随着社会的发展，患者的法律意识和自我保护意识日益增强，对医疗服务的要求也越来越高，医护人员的治疗风险越来越大。面对复杂的医院环境，医护人员紧张、不安、焦虑的情绪时常会出现。

语言因素分析

语言是人们进行正常沟通交流的最直接，最方便、最明白桥梁，医患沟通的语言层面更是医患冲突产生也是最直接的影响因素。患者及家属到医院看病就医的诊疗过程中患者及家属均须要与医护人员就病情方面进行全面的沟通与交流，在讨论病情发展过程中，有些医护人员使用大量的医学专业术语对患者及家属解释病情，然而患者又没有足够的医学背景知识来理解，这样就会很容易导致医护人员和患者及家属的沟通不顺利。所以，医护人员在与患者及家属面前进行就病情交流时，就要考虑到患者及家属对医学术语的缺乏和医学知识的水平，所以在讲述病情时，尽量简化或白话、

中国知网 https://www.cnki.net

通俗易懂一些。如此一来，患者及家属会很快理解，对之后的治疗沟通就方便很多。[43]课题研究中，笔者对患者对医护人员语言因素进行了评价。

根据对患者的调查，可以明显感到医护人员由于受工作压力大、工作任务繁重等因素的影响，较少或者不太在意一些反映正能量的语言的应用，对笔者所列“热情地问候”、“使用通俗的语言”、“鼓励提问”、“对叙述感兴趣”等方面，从调查统计数据来看，语言因素是制约医患关系的重要方面，必须认真对待，进行合理解决。

情绪因素分析

医护人员是医院为患者及家属提供医疗服务的主要对象，医护人员的情绪会对患者产生不可忽视的影响。通过对患者问卷调查反馈，可以看出，患者对医护人员的情绪反应比较强烈，也从另一方面反映了医护人员的情绪也会感染和影响患者的情绪，医务人员良好的情绪对于患者积极配合治疗、提高治疗效果等方面，具有十分重要的作用。

行为因素分

医护人员的行为对医患之间的沟通也尤为重要，根据相关研究报告显示，在人类的第一印象中，有一半是来自于肢体语言。因此，行为的第一印象十分重要。肢体语言沟通是指除了通过使用语言之外可以表达自己的情绪，传达给周围的人一种行为。比如常见和感受深刻的眼神、丰富面部表情、侧耳的聆听、身体动作、以至于认得一个声调度可以进行沟通。笔者在访谈过程中，曾经了解到这样的一个案例：一位刚刚怀孕的妇女在门诊就诊，患者主要是确定自己是否怀孕以及怀孕多长时间，目前需要做哪些检查，注意些什么，可是医生低头只顾看自己的手机，只有她的学生在与患者交流，还面无表情，只顾自己说话，不听患者的描述，患者多问几句就表现出不耐烦的表情。最后开了诊断书，只说去做检查，也不说检查完后怎么样。患者从门诊出来后就说再也不找这个医生看病了，哪怕多等会也要找一个能好好说话的医生。这就说明了医护人员的行为，哪怕是一个口气都会对患者心理产生的影响。所以，当我们在用语言交流时，无声的行为也会是沟通助力。双方良好的结合能够更加有效。

（3） 医患双方质性研究的结果讨论

存在的主要问题

根据大量的问卷调查和一对一的访谈，通过分析可以发现医患沟通所存在的主要问题：医护人员的沟通能力令人堪忧，患者评价频数中对医护人员的沟通能力整体评价不高。由于医务人员受工作量大，任务繁重等客观条件的限制，使得其在认知方面

中国知网 https://www.cnki.net

特别是语言、情绪、行为等因素所受影响较大，因而医护人员与患者之间的沟通水平还有很大的上升空间。

成因分析

医患之间产生冲突，一个十分重要的方面就是医患之间缺乏有效的沟通，通过访谈，笔者了解到，医患出现沟通问题主要成因在于以下几个方面：

A　认知存在偏差

由于医护人员和患者及家属均对双方的沟通的重要性认识不足，以及在医院只是治疗患者的自身疾病，从而忽略心理上的重视，造成其沟通的意愿变低，有的甚至把自己完全封闭起来，人为造成了沟通的障碍。患者全身心地把自己的生命交给了医护人员，然而医护人员由于受工作繁重，心理压力大等客观因素的影响，导致其与患者的沟通意愿变得十分低下，对沟通的重要性认识不足，特别是忽视了对患者心理进行抚慰，使得医护人员和患者及家属之间的关系出现不和谐因素。

B　语言沟通存在偏差

语言是人们进行正常沟通交流的重要桥梁和媒介，医患沟通中语言更是沟通不畅的一大重要影响因素。患者看病就医的过程中患者需要与医护人员就如何治疗自身疾病进行详细的交流与沟通；而在向患者介绍病情的过程中，大部分医护人员会使用大量的医学专业术语，然而绝大部分患者并不具备足够医学专业知识来理解医生对疾病的描述，如此就会发生医患之间的沟通不畅。

C　医护人员态度存在偏差

当前很多医院都长期处于超负荷运转状态，医护人员压力大，导致一些医疗机构为“赶任务”，放低了服务标准，一些公立或私立医院存在的一号难求、面无表情、说话伤人等现象；一些医护工作者只注重自己治病的技术水平程度而忽略了与患者的良好沟通和交流，忽视了人文关怀的重要性，使得其与患者交流时，说话生硬，没有感情，造成患者误解和反感。当前医院把重点放在诊疗的过程而忽视了对患者及家属的心理关怀。有相关研究显示，医患关系得紧张，到双方的水火不容，以至引发的医疗纠纷，有很大一部分是由上述引起的。

中国知网　https://www.cnki.net

2.7 问卷的信度与效度检验

本研究的调查问卷是在查阅了大量相关文献的基础上修订的，具备调查问卷的条件。从研究实施的环境而言，我们有比较好的空间和依从性较好的被试，保证本研究的顺利进行。从参与研究的人员来说，研究本人为主体，同时另有研究生一人辅助参与其中，为本研究的顺利进行提供了保障。

效度检验采用研究参与者的检验方法。研究参与者检验就是把研究结论反馈给研究参与者，看其反应和评论。在本研究中，研究者每次访谈结束后 72 小时内将交谈的音频转换为文本，转录并校对一次文本约用 10-12 个小时。接下来再对资料进行提取，提炼出更加有益于主题的问题以完善访谈提纲，有针对性的进行下一次访谈。并将转录的文字资料及研究结果以书面或电话的形式进行回访。同时，邀请参与调研人员对研究者分析所得的结论与个人实际情况的符合程度进行评判。得到参与者反馈后，进一步完善。

中国知网 https://www.cnki.net

3 对患者的个案干预研究

3.1 案例背景

根据认知心理学和质性研究的理论要求，为了全面了解患者沟通障碍认知情况，笔者对患者进行了个案干预研究。

3.2 研究对象

笔者选择了一位有典型性的住院患者，进行了患者沟通障碍认知分析。该患者为男性，年龄 54 岁，汉族，学历为初中，身份为农民，住院前在建筑工地工作。

3.3 患者背景资料

患者口述；

我当时正在工地上干活，和另外一个人拿撬往车里倒土，突然一个铁锹就砸在了我的右脚上，就有了口子，可是流血不多，觉得没事就到周围的小诊所包扎了一下，休息了一两天以后就没再管他。过了几天，划破的那给流脓了。就住医院了。医生说是感染了的住院。我就住进来了。后来检查发现患有糖尿病，情况不好，建议我把受伤的那个脚趾给切了，就是截肢手术。住了俩三天么，那个脚趾就越来越肿了。我就说赶紧做手术吧，不然挨着的那个也不好了，说不定也得切了呢。刚开始的时候说两三天就做呀，可是等了三四天了，医生说还得再看看。你说这一天天的，又是住院费又是输液药啥的，家里条件又不好，还不能干活。哎，这又不给做手术，他们就是想要点钱。不就是个开一刀么，你看看我的脚趾头都成这样了还不给我做手术！我就问大夫就给我做了吧，大夫就简单的说在等等吧，先看看情况，就走了，接下来就让我输液，输了五天之后，就给我做手术了，可是根本不行，做完后不久，旁边的那个也不行了，后来就又给我做了一次手术，这可是第二次手术了啊姑娘！这次他们把我的挨着的一个脚趾也给切了。我的脚这才慢慢好起来。你说，我说了要赶紧做手术的，

中国知网 https://www.cnki.net

他们（医生）不听，非要在等等，再等等，你看，你看看（患者很激动，抬起了脚让我看）。肯定因为他们不给我做手术个引起的！谁知道第一次动手术时咋做的呢！

3.4 作者了解的情况

随后从患者主治医师处了解到的实际情况是：患者在住院期间血糖一直控制不佳，而血糖控制不佳的患者术后会出现伤口不愈合及感染等风险，于是医生先采取边控制血糖边观察的保守治疗方案。由于主治医师与患者沟通不及时，没有向患者将其病情及时解释清楚，造成患者误以为医生没有及时为其手术，从而导致其病情加重，因此患者对主治医生的方法呈现出了一些不利于病情的情绪，比如：不积极的配合吃药、输液，与主治医生和护士的沟通不顺畅等。在适当的时间主治医生为患者做了手术，主要是将患者的踇趾和与其附近关节切除，但是术后的情况并没有向预期得到u恢复，而是更加严重，发生伤口感染，治疗方法是继续做第二次手术。而二次手术切除范围扩大，但这次手术顺利，需要后期密切的观察伤口变化及愈合。由于做了两次手术，切除范围又比预期的大，因此，患者对主治医生产生了不小的抱怨。认为造成第二次手术就是因为主治医生没有给他及早的手术，耽误了病情。最终对主治医生和主管护士有着很多的不满和抱怨。

3.5 作者的观察

观察到患者的年龄比实际年龄偏大，皮肤黢黑，额头皱纹明显，手背血管突出，手掌老茧较多。患者脸色疲惫，憔悴，焦灼、焦虑，暴躁不安，但在交谈过程中较为配合，语速较快，能表达自己的问题，愤怒的情绪明显，有自知力，愿意积极改变自己的现有的状态。

3.6 家庭情况

该患者，年收入1.5-2万。已婚，有一子一女。儿子女儿都在外地打工，生活只能够自理，都没有结婚，想着给孩子们攒钱结婚用。妻子也是靠打工和家里的两亩地赚钱。

中国知网 https://www.cnki.net

3.7 情绪状况

患者有着两方面的顾虑，一是担心自己的病情到底怎么样，是否能治疗的自己想要的结果，二是承受着没有钱的焦虑，由于这两方面的顾虑，使患者出现焦虑、不安、暴躁等的不良情绪。住院期间无亲属陪侍，患者独自（妻子在家料理农活，偶尔来探视）面对疾病。这时，多重事件的积压与发酵，最终使患者不能承受而产生多种的长期的不良情绪。

3.8 社会功能

患者在与病房内的患者均可以很好的相处，并非常融洽，但是只要主治医生或是主管护士为其治疗或讨论治疗方案、病情时就会沉默不语，很少与之交流，仅仅是回答一些主要的问题。

3.9 心理测验的结果

SDS 得分:54 分；SAS 得分：50 分。

3.10 问题分析

3.10.1 患者与医生的沟通出现障碍——不信任

患者在入院检查后，医生只是告诉他脚趾感染是由于糖尿病引起的，就接受了医生的保守治疗，但结果不尽如人意，就进行了手术，结果术后效果不佳，又进行了二次手术。导致患者感觉自己受了二次伤害。因此患者开始怀疑自己的病是否与糖尿病有直接关系，以及二次手术是否由于医生的技术不精而直接导致的。患者最终将自己遇到的不幸都归咎到医生身上，由此导致患者不信任医院和医生，医患关系呈现紧张趋势。

其次，医生在与患者沟通时，只是简单的告诉患者你现在是什么情况，可能会发生什么情况，有几种治疗方法，你可以选择，但是最好的是哪一种。在患者还没有完

中国知网 https://www.cnki.net

全接受自己的病情的情况下，医生就已经在最短的时间内告诉了患者，当患者在问时，医生的用不耐烦的语气在一遍的重复了之前的话。并没有对患者表现出关心的表情和话语。在告诉患者早点做决定后就冷漠的转身走掉了。

3.10.2 患者的情绪问题

患者在进入医院后，通过检查得知自己有慢性的之前不知道的疾病——糖尿病，起先患者的情绪受到比较大的冲击，但是由于对疾病的治愈有着强烈的期望，暂时还是能够接受的。随后，由于医院采取的保守治疗方案，让患者担心自己的病情恶化，同时承受着病痛和经济的双重压力，因此一度产生焦虑、烦躁等不良情绪，从而使患者与医院关系紧张。患者在经过第一次截止手术后，尚能勉强接受自己病情和状态，但在内心已经有了一定的对主治医生不能够在第一时间手术的不满，当到第二次截肢手术结束时，由于此次的截肢的范围较大，担心日后的生活和工作会有很大的影响，不能够自理或无法赚钱，内心的不满和怨气不断积聚，但又没有办法改变现状，情绪不稳，出现焦虑、暴躁、沉默等不良情绪不愿再积极配合治疗，病情恢复缓慢。

3.11 进行干预

3.11.1 选用合理的干预理论

合理情绪疗法（RET）是由艾利斯提出的，又简称为ABC疗法，其中ＡＢＣ分别表示为：事件、信念或者认知、行为或者情绪。合理情绪疗法认为：任何问题的产生都会有一个主要原因，即为一些人的想法或者是认知与客观的存在的是不一样的，所以只好寻求帮助，纠正其非正常的观念、认知等。当纠正后，不良的症状就会随之消除。合理情绪疗法是通过纠正非正常的认知来减少不良情绪，进而使其能够运用正常的观念来生活。

3.11.2 咨询目标

从上述的情况可以对患者的心理问题进行初级的评估和诊断。在与患者认真仔细的商讨后，明确了下面两个咨询目标：

中国知网 https://www.cnki.net

（1）通过对患者的心理多方面、多角度、高强度的心理照顾，帮助患者消除其不良的情绪和非正常话的想法，减少其心理压力。

（2）根据患者自身疾病，与主治医生沟通后，帮助患者从基本的医学知识了解主治医生的治疗方案，理解医生。之后让医生与患者进行有效的沟通，使之逐步建立良好的医患关系。

3.12 咨询过程

通过有效的咨询，帮助他们认识到自己尚未解决的内部冲突、意识到内外世界的相互作用以及人的积极适应能力，才能帮助患者认识自己的内外世界。帮助患者总结自己在治疗过程中的经验教训、让患者学会评估自己的思维观念是否合理、帮助患者意识到他们陷入困境的原因主要来自自身认识，帮助患者纠正非正常的欲望和错误的观念，从而积极配合医护人员的治疗，尽快康复。

3.12.1 咨询阶段划分

咨询阶段大致可以分为：

①诊断评估与咨询关系建立的阶段

②心理帮助阶段

③结束与巩固阶段

3.12.2 具体咨询过程

第一阶段：一开始与建立起良好的关系，并在此之后进行诊断和评估。

首先与患者建立良好关系，收集所需要的相关资料和信息，对其产生的问题做初步评估，并明确患者的需求。通过倾听、共情、积极关注等方式来初步建立良好的关系。为下一阶段的治疗打好基础。

第二阶段：给予患者一个能够宣泄负面情绪的机会，在此期间做到倾听，不随意打断患者的叙述，适当的情况下安抚患者情绪，帮助患者明白自己目前最重要的事情是控制好自己的病情。其次，通过与患者的交流中，总结患者的不合理的观念。并与

中国知网 https://www.cnki.net

患者共同讨论和确认不合理的观念。（1）怀疑医生错误诊断伤口是由糖尿病引起的。（2）第二次手术是因为医生的医术不行。

第三阶段：（1）向求助者分享合理信念，通过自我暴露，举身边医生和患者良好的例子，使求助者学习处理此类问题的不同模式。（2）协助患者对自身所患疾病和目前病情的进展情况的全面认识，积极的让患者与主治医生进行有效的良好的沟通，使患者消除对医生的猜忌和怀疑，培养其对医生的信任感。（3）与此同时，和医生就患者的情绪和心理进行比较深入的探讨，对医生的言语和行为提出相对合理的建议及意见。

第四阶段：（1）让患者体会自己的情绪的变化。（2）谈谈对医生的看法的改变并体会对医生的信任感是否有变化。（3）结束干预。

3.13 干预效果评估

通过干预，通过患者自我评价、医护评价和作者评估，感到总体上达到了预期目的：

（1）患者自我评价："现在心情平静了很多，能够较坦然接受我的病情及手术过程了。也不总是抱怨医生和护士了。能够客观的理解他们了。

（2）医生护士评价："患者能够比较好的与我们交流了，也会说笑了，抵触情绪也少了，积极配合我们治疗了。"

（3）作者评估：通过对患者的回访，结合之前的咨询目标和内容，可以看到显示情况和预期是是相近的，患者基本消除了焦虑、愤怒等不良情绪。

（4）咨询测量的结果正常。SDS：25 分；SAS 得分 26 分。

3.14 讨论

患者面对医务人员的不解释、说话僵硬、表情麻木等肢体语言，以及对医生治疗方案的不理解，与此同时由于自身的原因致使患者出现焦虑、烦躁、怨言不断、不愿意回应护士等多方面不良认知。在对患者多次的接触中，选择适合患者的心理疗法，即对患者实施合理情绪疗法。进行多次的心理干预后，可以明显感受到患者的焦虑、

中国知网 https://www.cnki.net

烦躁等不良情绪有较好的缓解和改善。与之相应的情绪密不可分的语言和行为以及态度等方面也得到了明显的改善和好转。从而让患者和医务人员有了良好的沟通和交流。患者也康复出院，理解了医生治疗方案。

3.15 提升医患沟通水平对策措施

根据以上分析，笔者认为提供医患沟通水平，应当着重从以下几个方面着手，强化心理认知的干预，即行为干预、情绪干预和语言干预，不断提升沟通的水平和质量。

中国知网 https://www.cnki.net

4 结论与展望

4.1 研究结论

1.医患双方的认知因素能够影响医患沟通障碍。

2.医患双方良好的认知能够改善医患沟通障碍。

4.2 对策（建议）

1.心理干预

面对医护人员心理压力大、患者心理脆弱等问题，要着重从两个方面对出现偏差的医患沟通进行心理干预。首先，我们建立起医护人员和患者及家属之间的理解、尊重、信任的良好的关系。医患关系在复杂的社会关系中处于一种特殊的位置，是一种看似矛盾却最应该和谐的一种作为人际关系。在这种特殊的人际关系中，我们要加强对医护人员职业道德的教育，使其在心理上构建平等的医患关系，心怀坦荡，心理健康，既有利于对患者的治疗，又有利于个人的身心健康和成长进步。

2.行为干预

医生的行为会对患者的身心造成很大影响，甚至会影响到患者的治疗。医院要在显著的位置悬挂横幅标语，进一步营造文明就医、文明候诊、文明用语的良好氛围。要设立流动纠察岗，由医院纪检、宣传、人事、工会等组织共同组成，一方面，对医生不文明行为进行干预；另一方面，对患者不文明行为进行干预，使大家在文明的环境中受到行为的约束，进而营造医患双方平等、文明沟通的良好环境，增强医生的信心，坚定患者治疗的决心。

3.情绪干预

情绪无论是对医生，还是对于患者都是一个“定时炸弹”，不良的情绪会导致人的言行失态、行为失范。医患沟通交流过程中，医护人员的一言一行都会影响沟通的效果，处于疾病中的患者，其心理变得脆弱，情绪也很低落。因此，在医院工作的相关人员在与患者几家属时，应积极的首要的是安抚其心理的需求。此时要运用良好的

中国知网 https://www.cnki.net

沟通来安抚。同时，要加大对医护人员情绪监测，强化心理调适，防止因压力过大，导致情绪失控，造成医患冲突。

4.3 研究不足与展望

1.由于受时间、经费、学识等方面的影响和制约，对医患沟通障碍认知的质性研究还不够深入，有些领域还没有涉及到，有些研究还有待于进一步深入。

2.在以后的工作中，将继续发扬刻苦钻研的精神，不断对调查研究方案及问卷进行优化完善，对我们的医患沟通及医患关系做出一点积极的切实可行的方案。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 谈建伟； 陈岚； 高彦峰； 黄雪丽； 朱振婷； 李斌.浅析小型医疗机构医患纠纷的防范与处理[J].甘肃科技,2013(16):83-84.

[2] 唐兰叶.中外医患矛盾现状与研究[J].岁月（下半月）,2012(4):81-82.

[3] 管亚茹.失衡的“天平”——试论社会工作在医患关系中的介入途径[J].河南司法警官职业学院学报,2014(4):71-74.

[4] Epstein RM, E Hundert. Defining and assessing professional competence.JAMA,,2002. 287(2): 226-35.

[5] G Makoul,JCJM De Haes.Teaching, Assessment, and Research: Papers from the Communication in Medicine Conference Series. Patient Education & Counseling.2001, 45(1):1-2.

[6] 周冀英,谭戈.加强医患沟通刻不容缓[J].医学教育探索,2006(4):363-364.

[7] 刘书文,浅谈医患沟通的必要性和内容[J].中国卫生事业理,2005(10):638-639.

[8] CW, Lazare A, Lipkin M Jr.. Effect of communicationstraining on medical student performance. JAMA Yedidia MJ, Gillespie CC, Kachur E, Schwartz MD, Ockene J, Chepaitis AE, Snyder,,2003. 290(9): 1157-65.

[9] L.M.L. Ong1, M.R.M. Visser1, I.P.M. Kruyver, J.M. Bensing, A. Van Den Brink-Muinen, J.M.L. Stouthard, F.B. Lammes and J.C.J.M. De Haes.The Roter Interaction Analysis System (RIAS) in oncological consultations:psychometric properties.Psychooncology,1998.7(5): 387-401.

[10] DL Roter, Bsensing JM, R Hulsman. Communication patterns of primary care physicians in the United States and the Netherlands. J Gen Intern Med, 2003.18(5): 335-42.

[11] 侯胜田.医患沟通的主要障碍、影响因素与改进方法[J].医院院长论坛,2003(3):33-36.

[12] 王莹.加强医患沟通,构建和谐医患关系相关方法的探究[J].求医问药（学术版）,2012(5).

中国知网 https://www.cnki.net

[13] DS Van，M Nübling，W Langewitz. Doctors' responses to patients'concerns: an exploration of communication sequences in gynaecology.Epidemiol Psichiatr Soc, 2003. 12(2): 98-102.

[14] DL Roter，NK Russell.Validity of physician self-report in tracking patient education objectives. Health Educ Q, 1994. 21(1): 27-38.

[15] D L, Roter,J A Hall,D E Kern,L R Barker,K A Cole,R P Roca. Improving physicians'interviewing skillsand reducing patients' emotional distress. A randomized clinical trial. ArchIntern Med, 1995. 155(17): 1877-84.

[16] 重庆市卫生局.重庆医科大学儿童医院实行医患沟通制的举措、推广与体会.中国卫生质量管理,2003. (1): 54-57.

[17] 彭红,李永国.医患博弈及其沟通调适.博士学位论文-中南大学,2008,R-052.

[18] 王宗海,向焱彬,冯爱娟.根据《全球医学教育最低基本要求》分析我国高等医学教育存在不足.现代医药卫生,2004. 20(12): 1188.

[19] 顾加栋，医乃仁术:儒家伦理与医学职业道德建设[J].中国医学伦理学，2008.21(6):30-31,34.

[20] 冯云红.良好的医患沟通是构建和谐医患关系的保障[J].中国中医药咨讯,22011, 03(12):56-56

[21] Julie M. Schirmer,Larry Mauksch,Forrest Lang,M. Kim Marvel,Kathy Zoppi, Ronald M.Epstein,Doug Brock,Michael Pryzbylski.Assessing communication competence：a review of current tools[J]．FamMed，2005,37(3)：l84-192.

[22] 袁晓玲,赵爱平. 医患沟通技能评价方法的研究进展[J].护理学杂志,2010,5(10):91-93.

[23] ACGME/ABMS Joint Initiative Toolbox of Assessment Methods Version 1.1 2000.

[24] 吕力, 张毅萍, 王进进,刘英.360 度反馈评价在医学教育临床教学中的运用[J].中国高等医学教育.2007 (11):52-69.

[25] 叶倩.护理专业大学生护患沟通能力的结构分析及评价工具的初步研究[D].第二军医大学, 2004，R-4.

[26] 彭红.医患博弈及其沟通调适[D].中南大学,2008,R-052.

中国知网 https://www.cnki.net

[27] 李娟.用 SEGUE 量表对医学生医患沟通技能评价的研究[D].中国医科大学,2008，R192.3.

[28] 张阳.住院医师沟通能力与职业道德的 360 度评价研究[D].中国医科大学,2010，R197.3.

[29] 陈向明.质性研究:反思与评论[M].重庆大学出版社,2008:7-13.

[30] 陈向明.教师如何做质的研究［M］.北京：教育科学出版社,2001:12-163.

[31] Streubert HJ, Carpenter DR. Qualitative research in nursing[M]. Philadelphia,1995.

[32] 王明旭.医患关系学[M].北京:科学出版社,2008.

[33] Adrienne Shaw, Saima Ibrahim, Fiona Reid.Patients'perspectives of the doctor–patient relationship and information giving across a range of literacy levels [J].Patient Education and Counseling, 2009, 75(1):114-20.

[34] 王锦帆.医患沟通学(2 版)[M].北京：人民卫生出版社,2006.

[35] 杜治政.守住医学的疆界[M].中国协和医科大学出版社 2009.11.75.

[36] P Lukoschek,M Fazzari，P Marantz. Patient and physician factors predict patients' comprehension of health information.[J] Patient Education & Counseling,2003,50(2):201-210.

[37] 周庆环，李红，王杉,徐燚.北京大学七年制医学生人际沟通能力培养模式初探[J].医学教育，2003(6)：13-15.

[38] 吴均林.医学心理学[M].第 1 版.高等教育出版社,2006:14.

[39] 罗萍,曾志羽,覃红,李小萍，胡振，罗红叶. 医患双方对医患关系及医疗职业认知差异的研究[J].中国医院.2009,13(8):31-32.

[40] 吴均林.医学心理学[M].第 1 版.高等教育出版社,2006:116.

[41] 凌建勋,凌文辁.深入理解质性研究[J].社会科学研究,2003(1):151-153.

[42] Robinson. Effective doctor patient communication: building bridges and bridging barriers[J]. Can J Neurol Sci, 2002,29(2):30-32.

[43] 侯胜田.医患沟通的主要障碍、影响因素与改进方法[J].医院院长论坛,2013(3):33-36.

中国知网 https://www.cnki.net

附　录

附录一　医患沟通现状调查问卷(医务人员)（略）

附录二　医患沟通现状调查问卷(患者)（略）

附录三　访谈和录音同意书知情同意书（略）

附录四　录音同意书（略）

附录四　访谈信息登记表（略）

附录五 《抑郁自评量表》（略）

附录六《焦虑自评量表》（略）

中国知网　https://www.cnki.net

致 谢

回看自己在山西医科大学的研究生几年来的自己，期间的经历是那么值得回味。其中包含着多少酸甜苦辣，多少笑声和泪水，每一种滋味，每一个表情都是那么让我值得慢慢回味，慢慢品尝。

在这里我需要感谢好多人，是因为有你们的帮助才能让我的人生有着如此值得留恋的地方。

山西医科大学这座百年老校是我生命中就学时间最长的学校，承载了我从本科到研究生的近十年的时间。这所学校给了我她的认真、努力、敬业的精神。让我在做每件事的时候都回想起她带给我的品质。

最应该感谢的是我的研究生导师，我的论文在您认真、悉心的指导下完成的。从文章的选题、到开题报告的完成、再到论文的完成均是导师耐心的指导下完成的。在论文完成中，导师给了我很多的宝贵的修改意见和针对性的问题。再次对导师的帮助和指导致以诚挚的谢意。

感谢支持本文研究的山西省忻州市中心医院的医务人员和患者及家属，没有你们的积极配合，就不会有这篇论文的诞生。

感谢我的同窗好友、我的同门、我的师姐师妹师妹们，是你们在我无助时给予我力量，在我泪水时给予我安慰，在我开心是和我一起疯。谢谢你们的陪伴。

最后，感谢一直以来支持我的父母！他们是我最坚实的后盾，不论我遇到何种问题，他们都给予我无私的支持与帮助，使我在困难面前，有勇气战胜一切困难。再次感谢感谢我的父母。以及一直默默陪伴在我左右的另一半，是你包容我的坏脾气，才不会让我失去那么多好朋友，才能够开心的面对新的一天。谢谢你老公。

感谢为本文做出评审的老师们，抽出忙碌的时间给予我宝贵的意见和建议。

再次谢谢大家，谢谢研究生期间的每一个人，谢谢！

中国知网 https://www.cnki.net

研究成果

[1]李杰，姜峰.情绪孤独大学生心理特点的调查分析[J].课程教育研究,2015.7；279-280.

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net